PCOS는 생리와 대사 건강을 함께 봅니다

다낭성난소증후군(PCOS)은 성인에서 흔한 배란장애의 원인입니다. 초음파 모양 하나로 진단하지 않습니다.

성인은 3가지 중 2가지 + 다른 원인 배제



성인의 PCOS는 배란장애·고안드로겐혈증·다낭성 난소 형태 중 2가지를 충족하고 다른 원인을 배제해 진단합니다.

진단에 쓰는 단서를 풀어보면

진단 단서	어떤 의미인가요
배란장애	생리 간격이 길거나 불규칙한 경우가 단서가 됩니다.
고안드로겐혈증	남성호르몬 작용이 과한 상태. 다모증·여드름·남성형 탈모나 혈액검사로 평가합니다.
다낭성 난소 형태	초음파의 난소 형태를 봅니다. 성인은 항뮐러관호르몬(AMH) 상승을 형태 기준 대신 활용할 수도 있습니다.

청소년 기준은 다릅니다

배란장애와 고안드로겐혈증, 둘 다 평가합니다

청소년에서는 두 조건을 모두 충족해야 하며, **초음파 형태·AMH는 진단 기준에 쓰지 않습니다.** 한 가지만 있으면 위험군으로 추적하고, **초경 후 8년** 시점에 재평가한다고 설명했습니다.

광교바른내과 의원
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · 031-893-4560
평일(월–금) 08:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
토요일 08:30 – 13:30 · 일요일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

본 자료는 일반 안내입니다. 약의 시작·용량·중단은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

생리만 맞추기보다 치료 목표를 함께 정합니다

피임과 임신 계획, 여드름·다모증, 체중 변화와 당대사 상태를 함께 이야기하세요.

비슷한 증상을 만드는 다른 원인

감별할 원인	진료에서 확인하는 단서·검사
임신 · 갑상선 · 프로락틴	임신검사(β-hCG), 갑상선(TSH), 유즙분비호르몬(프로락틴)을 살핍니다.
부신 관련 질환	선천성부신과형성증은 이른 아침 17-OH 프로게스테론 검사. 쿠싱증후군이 의심되면 24시간 소변 유리코르티솔 등으로 평가합니다.
에너지 부족 · 난소기능 저하	체중·운동·스트레스 이력과 LH·FSH·에스트라디올(E2)로 FHA·조기난소부전(POI)을 구분합니다.

마르더라도 당대사 평가를 합니다

강의에서 권고한 검사: 75g 경구당부하검사(OGTT)

연자는 **모든 PCOS 의심 환자**에서 비만이 아니어도 **75g OGTT**로 당대사 이상을 살펴야 한다고 설명했습니다. 당을 처리하는 몸의 반응을 보는 검사입니다.

생활습관·피임 목표에 맞춰 치료합니다

강의의 성인 PCOS 사례

22세, BMI 27kg/m², 최근 **2년간 6kg 증가**, 생리는 **3~6개월마다** 하고 여드름·다모증이 있던 사례입니다. 교재에서는 생활습관 교정과 **5~10% 체중 감량 목표**를 제시했습니다. 피임도 필요해 복합경구피임제로 주기와 고안드로겐 증상을 함께 관리했습니다. 개인의 임신·피임 계획에 맞춰 치료를 정합니다.

오래 생리가 없으면 다시 평가받습니다

이사라 연자 Q&A

3개월 이상 무월경이면 LH·FSH·E2·프로락틴·TSH 등 기본 평가가 필요하다고 답했습니다. 에스트로겐이 높은 상태에서 무월경이 **3개월 이상** 이어지면 자궁내막 증식증·암의 위험을 평가하고 PCOS 가능성도 살펴야 한다고 설명했습니다.

광교바른내과 의원
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · 031-893-4560
평일(월–금) 08:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
토요일 08:30 – 13:30 · 일요일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

본 자료는 일반 안내입니다. 약의 시작·용량·중단은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gynecology/pcos-menstrual-metabolic-asan28/